RadiographXpress

Manual de Usuario:
Médico de Interpretación (Radiólogo)

Clínica RadiographXpress

22 de abril de 2026

Resumen

¡Bienvenido a tu estación de trabajo en RadiographXpress! Como Médico de Interpretación o Radiólogo en jefe, tienes el rol operativo más crítico: dictaminar las imágenes médicas, redactar los hallazgos clínicos y sellar legalmente los estudios. Este manual documenta tu experiencia técnica a través del entorno seguro y la consola de reportes.

Índice

1. Acceso Seguro y Validación Institucional **3**
1.1. La Firma Digital (Configuración Crítica) 3

2. Inicio de Sesión en la Plataforma **3**

3. Gestión y Bloqueo Inteligente de Estudios **3**
3.1. El Tomado de Casos Clínicos (Locking) 4

4. Listado de Trabajo (Worklist) y Tablero **5**
4.1. Sincronía Asíncrona PACS 5
4.2. Organización del Panel (Pending y Completed) 5

5. La Consola de Reporte **6**
5.1. Ajustar el Tamaño de Pantalla (Resizer) 6
5.2. Llenado y Envío del Reporte 7

6. Archivo y Trazabilidad (Historial de Reportes) **7**
6.1. Consulta Retrospectiva 8

1 Acceso Seguro y Validación Institucional

El ecosistema médico de RadiographXpress restringe severamente las aperturas de cuenta de rango dictaminativo. Como parte del staff médico interno, recibirás tus credenciales maestras (Correo y Contraseña inicial) de manera encriptada y directa por parte del equipo gerencial o departamento de TI.

1.1 La Firma Digital (Configuración Crítica)

Para estampar formal y legalmente los resultados clínicos, cada documento PDF generado por el sistema requerirá anexar irremediablemente una captura inyectada de tu firma física, sellando la hoja y dotándola de la validez obligada por las autoridades sanitarias.

IMPORTANTE: CAPA DE SEGURIDAD GERENCIAL

RadiographXpress dictamina que ningún médico (incluido un Radiólogo interno) posee los privilegios suficientes para subir o alterar por sí mismo el archivo fotográfico de su firma directamente desde su vista de perfil interactivo.

Se trata de una medida estricta antifalsificación. **Para vincular tu "Firma Autógrafa" a tu cuenta de operador, debes proporcionar tu firma original o escaneada (PNG transparente) al equipo administrativo/gerencial.** Ellos, haciendo uso avanzado de la interfaz, serán los únicos dotados con las credenciales necesarias para cargar la fotografía permanentemente en la base de datos de tu perfil.

Hasta que esto ocurra, las emisiones formales PDF de tus estudios se truncarán por cadencia métrica visual, invalidándolas frente al paciente.

2 Inicio de Sesión en la Plataforma

Una vez que el personal gerencial te ha entregado tus credenciales y ha configurado correctamente tu firma digital, estás listo para acceder al entorno de dictaminación de RadiographXpress.

1. Abre el navegador web (preferentemente las versiones más recientes de Chrome o Firefox, por estabilidad en la renderización de imágenes biomédicas).
2. Dirígete a la URL oficial de la clínica RadiographXpress.
3. En la pantalla principal, localiza el portal de autenticación e ingresa tu **Correo Electrónico** y tu **Contraseña**.
4. Haz clic en el botón de Ïniciar Sesión".

El sistema verificará automáticamente tu rol interno. Al reconocer tus privilegios como "Médico de Interpretación", la plataforma omitirá el portal de pacientes o asistentes, y te enviará de manera unificada y directa hacia tu consola principal de radiología (Dashboard).

3 Gestión y Bloqueo Inteligente de Estudios

En esquemas multi-médico, existe un riesgo inherente de colisión documental y duplicidad de esfuerzo. Para suprimir matemáticamente la posibilidad de que dos especialistas internos diagnostiquen las imágenes de un mismo paciente a la par o se pisen sus avances lógicos, el sistema blande la lógica estricta del **Estudio Bloqueado** *(Locking)*.

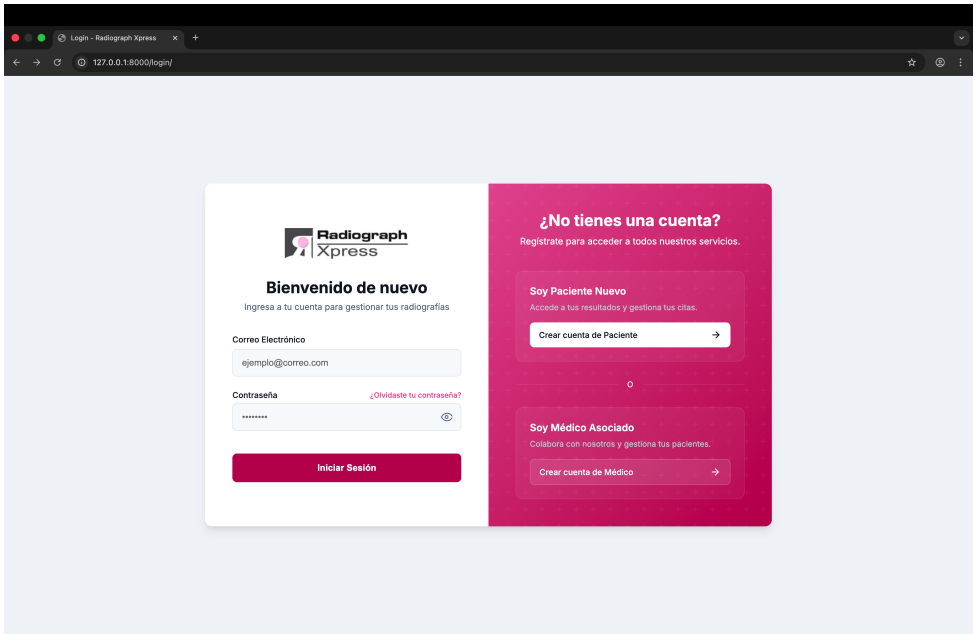

Figura 1: Pantalla de inicio de sesión universal.

3.1 El Tomado de Casos Clínicos (Locking)

1. Dentro de tu lista de urgencias pendientes, localiza el estudio que deseas diagnosticar y ábrelo visualmente.

2. **Activación por Interacción:** El bloqueo no se inicializa de inmediato. El mecanismo de candado arranca **en el preciso instante en el que comienzas a escribir** la primera letra dentro de la plantilla del reporte.

3. Al empezar a redactar, una notificación emergerá instantáneamente en la esquina superior derecha indicándote que has tomado posesión del estudio. Su estatus evolucionará inmediatamente a **"En Progreso"**.

4. **Autoguardado en Sesión:** Todo progreso y texto redactado quedará guardado dinámicamente en tu sesión activa en la plataforma, pudiendo retomar el estudio desde la sección de .Estudios en Progreso"sin perder la línea investigativa.

5. **Candado Maestro:** Desde la fracción precisa del bloqueo, dicho dictamen clínico **quedará blindado exclusivamente a tu cuenta**. Los demás médicos verán desvanecerse el requerimiento de su bandeja principal.

PRECAUCIÓN SEVERA: DESTRUCCIÓN DE PROGRESO POR SESIÓN

Abordar un estudio mediante el "Lock" es un contrato lógico asertivo. **Si tú, como operador responsable, cierras el navegador, o pulsas en "Cerrar sesión" voluntariamente mientras abrigas en tu bandeja un estudio en la fase "En Progreso", ocurrirá lo inevitable:**

El servidor, reventará el bloqueo forzadamente, restituyendo la tarjeta hacia la canasta universal global para que otro médico pueda reportar. Consecuentemente, todo avance, borrador o texto que habías introducido previo al cierre de sesión **será desechado**.

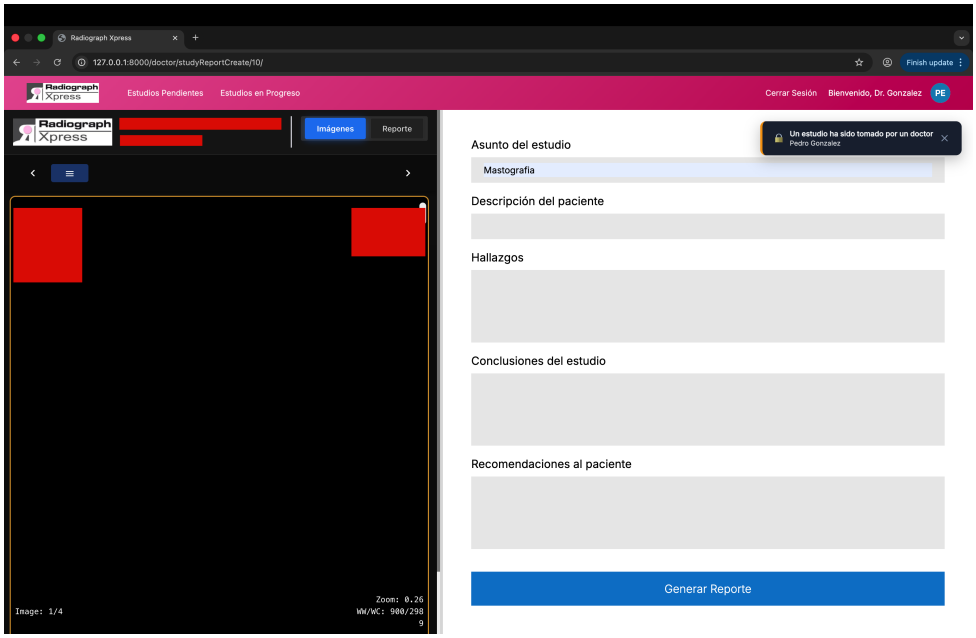

Figura 2: Notificación que avisa al doctor del bloqueo de estudio.

4 Listado de Trabajo (Worklist) y Tablero

Tras corroborar exitosamente tus accesos y tu firma, la primera ventana que te recibirá siempre será tu Dashboard General. Este funge directamente como tu **Worklist** institucional: el centro neural donde los equipos de radiología emiten sus salidas y tú las ingestas para diagnosticar.

4.1 Sincronía Asíncrona PACS

RadiographXpress funciona comunicándose con modalidades externas PACS. **Las actualizaciones fluyen en tiempo real**, por lo que el tablero parpadeará o se refrescará pasivamente cada cierto tiempo.

4.2 Organización del Panel (Pending y Completed)

Notarás tu pantalla dividida en segmentos estratégicos basados en el estado del dictamen:

- **Estudios Pendientes ("Pending"):** Representa propiamente la seccion de 'Estudios Pendientes'. Son todos aquellos expedientes y transferencias de imágenes provenientes de los técnicos que han llegado al servidor pero aún *no han sido explorados por ningún doctor*. Si visualizas estudios listados aquí, tu labor principal es tomarlos.
- **Estudios Terminados ("Completed"):** Es tu propio registro de éxito. Colecciona históricamente la base de tu productividad (estudios que redactaste de inicio a fin satisfactoriamente). Esta sección se ubica dando clic en tu nombre de perfil y viendo el historial de reportes realizados.

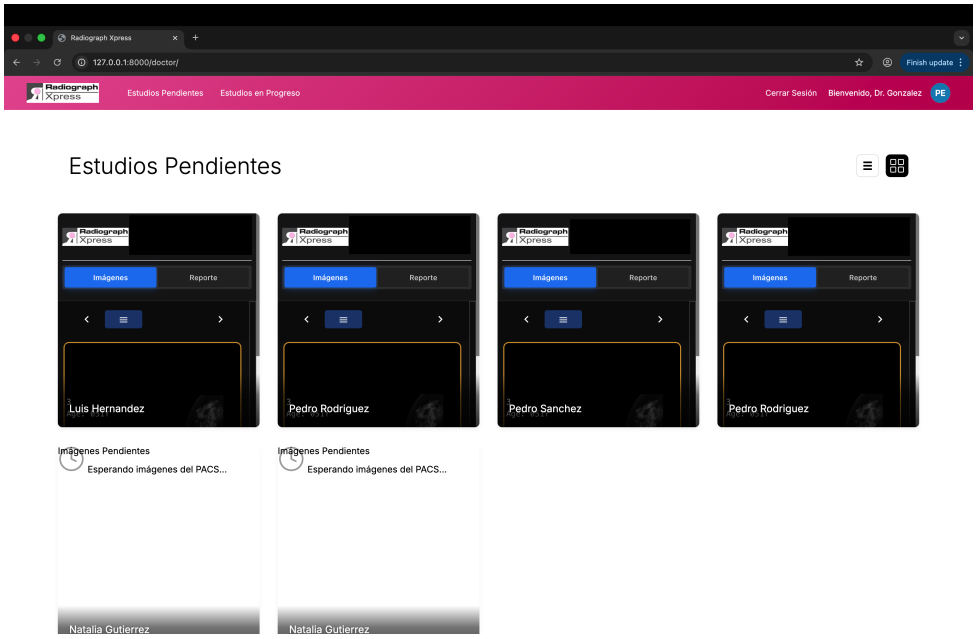

Figura 3: Tablero de radiólogo con una clara segmentación por progreso de estudio.

5 La Consola de Reporte

Al dar clic en un estudio, entrarás a la pantalla de redacción de reportes, dividida en dos partes.

5.1 Ajustar el Tamaño de Pantalla (Resizer)

Puedes ajustar el tamaño del visor o del área de texto según lo necesites:

1. La mitad izquierda muestra el **Visor Nativo PACS** para ver las imágenes. La mitad derecha contiene el formulario de reporte.
2. Entre ambas partes, hay una barra divisoria vertical delgada en color gris.
3. Haz clic y mantén presionado sobre esta barra, y **deslízala hacia la izquierda o derecha** para expandir el panel que necesites.
4. Al soltar el clic, el tamaño del visor y del reporte quedarán ajustados a tu comodidad de lectura y escritura.

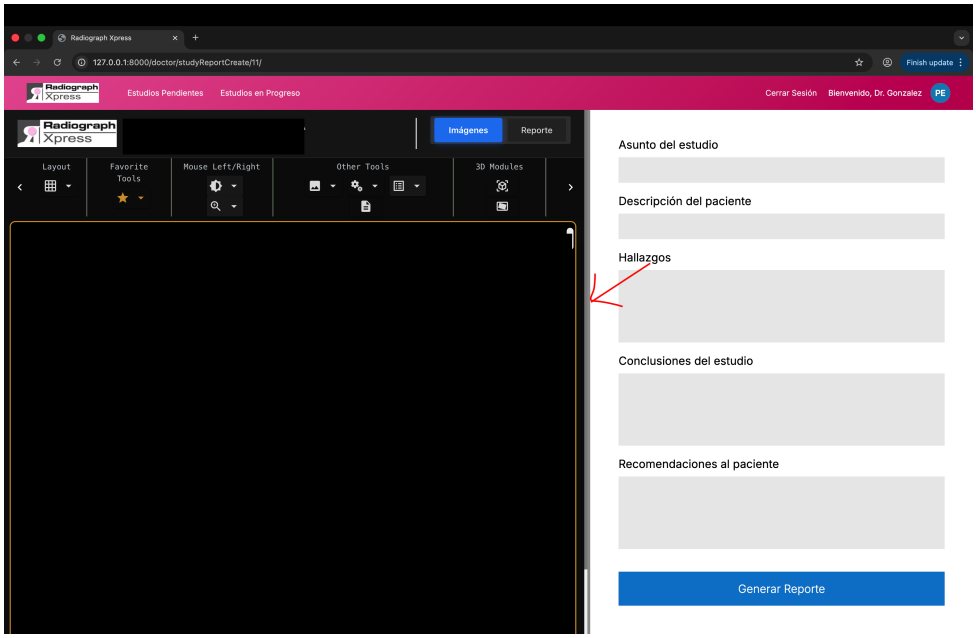

Figura 4: Ajustando el tamaño del visor PACS.

5.2 Llenado y Envío del Reporte

En el lado derecho encontrarás los campos necesarios para redactar tu estudio:

- **Asunto del estudio:** Información acerca del procedimiento u objetivo del estudio.
- **Descripción del Paciente / Notas de Envío:** Información brindada por el médico tratante o recepción. Puedes modificarla si está incompleta o es necesario aclarar algo.
- **Hallazgos (*Findings*):** Descripción física y anatómica directa de lo que observas en las imágenes (dimensiones, formas, fracturas).
- **Conclusiones del Estudio:** Tu diagnóstico médico final sobre las imágenes analizadas.
- **Recomendaciones al paciente:** Sugerencias adicionales para el doctor tratante, como solicitar pruebas de ultrasonido extra o pruebas de laboratorio.

Para finalizar el reporte:

1. Revisa la ortografía de tu texto.
2. Ve hasta el final de la página y da clic en el botón **"Generar Reporte"**.
3. El sistema agregará tu firma digital al PDF automáticamente y cambiará el estado del estudio a *Çompletado"*.
4. A partir de este momento, el paciente y los doctores podrán descargar y ver el archivo PDF oficial con tus resultados.

6 Archivo y Trazabilidad (Historial de Reportes)

Tu nivel jerárquico como emisor de juicios te garantiza acceso omnisciente al compendio de reportes culminados a lo largo de tu trayectoria vitalicia en la clínica.

6.1 Consulta Retrospectiva

Eventualmente, pacientes foráneos regresarán en citas de seguimiento o doctores asociados podrían invocar correcciones puntuales exigiendote refutar un diagnóstico antiguo de años previos.

1. Dirigete a la sección de tu perfil, dando clic en tu foto o nombre.
2. Sitúate en la columna o sector denominado firmemente como **"Estudios Terminados"**.
3. Puedes navegar ilimitadamente por el conjunto listado, localizar el reporte referenciado y dar clic en el.
4. Accederás a la radiografía estática íntegra del pasado como si formaras parte integral del flujo de vida del paciente.
5. Puedes releer detalladamente tu nota pericial con las descripciones, hallazgos o conclusiones antiguas.

Si detectas un fallo técnico durante la renderización de un reporte o un error severo en un paciente, por favor eleva un ticket inmediato con Gerencia.